

시 정 사 항

1. 제 목 : 포괄수가(DRG)지불제도 운영 부적정

2. 관계기관 : ○○·■■·▣▣병원

3. 내 용 : ○○병원에서는 4개 진료과 8개 질병군에 대해 포괄수가지불제도¹⁾를 2002년부터 시행하고 있으며, 2015년 포괄수가지불제도 운영실적은 [표 1]과 같습니다.

[표 1] 2015년 포괄수가지불제도 운영실적

(단위 : 건/원)

구분	A과	B과	C과	D과	계
건수	12	337	667	918	1,334
총진료비	14,419,677	533,693,623	166,489,176	1,344,626,828	2,059,229,304

우리나라 의료기관의 요양급여비용산정은 크게 행위별 수가지불제도와 포괄수가지불제도로 운영하고 있는데,

① 행위별 수가지불제도는 「국민건강보험법」에 의한 요양급여를 실시하고 행위에 대한 비용을 ‘건강보험요양급여비용’의 분류항목별로 정해진 수가를 합산하여 진료비를 산정하는 방식과

② 포괄수가지불제도는 「국민건강보험법 시행령」제21조제3항제2호 및 「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 제8조제3항에 따라 특정 8개 질병군에 대한 입원진료를 하는 경우에 행위별 수가와 상관없이 정해진 금액만 산정하는 방식으로 나누어 진다

1) 포괄수가지불제도(Diagnosis Related Group) : 입원환자를 수술, 처치명, 연령, 진료결과 등에 따라 유사한 환자군으로 분류, 사전에 정해진 진료비를 지불하는 제도, 포괄수가제도를 적용 받게되는 환자는 의료기관에 입원시 어떤 질병의 치료를 위하여 내원하였는지에 따라 정해진 금액에 합병증 및 입원일수를 적용하여 계산한 진료비만을 부담하게 되는 것이다.

포괄수가지불제도는 미국의 예일대학 팀에 의해 1960년대 말부터 10여 년에 걸쳐 병원의 산출물을 정의하기 위해 개발된 입원환자 분류체계이며, 모든 입원환자들이 주진단명 및 기타진단명, 수술처치명, 연령, 성별, 진료결과 등에 따라 진료내용이 유사한 질병군으로 분류되는데, 이때 하나의 입원환자 분류군을 DRG라고 부르며,

우리나라는 ^^^^공단에서 요양급여비용의 청구데이터를 활용하여 DRG 분류체계를 확립하고 1997년 맹장수술을 시작으로 2001년까지 자연분만, 맹장수술, 백내장수술, 제왕절개, 치질수술, 탈장수술 등 발생 빈도가 높은 8개 질병군에 대해 포괄수가제를 3년간 시범 실시 후 2002년 원하는 의료기관으로 확대되었습니다. 정부는 2012년 자연분만, 맹장수술, 백내장수술, 제왕절개, 치질수술, 탈장수술 등 발생 빈도가 높은 8개 질병군에 대해 포괄수가제를 의무화하였습니다.

따라서 ○○병원에서는 포괄수가 대상자의 진료비는 정해진 진료비 범위 내에서만 산정할 수 있기 때문에 최대한으로 행위별 진료비가 포괄수가 진료비를 초과하지 않도록 관리하여 병원 경영수지에 손실이 발생하지 않도록 하여야 합니다.

그런데 2014년~2015년 ○○병원의 포괄수가지불제도 대상자의 포괄수가 진료비와 행위별 진료비를 비교 분석한 결과, 충수염환자에게 항생제치료 및 CT검사 등의 사유로 인해 [표 2]와 같이 사비환자 행위별 진료비가 포괄수가 진료비보다 31,165,653원 초과된 것이 확인되었습니다.

[표 2] 사비환자 포괄수가 대비 행위별 진료비 초과현황

(단위 : 원)

진료과	건수	포괄수가진료비(A)	행위별 진료비(B)	초과진료비(A-B)
A과	10	11,214,838	12,219,464	△1,004,626
B과	101	182,844,391	207,040,321	△24,195,930
C과	7	18,385,323	20,860,543	△2,475,220
D과	18	23,371,420	26,861,297	△3,489,877
계	136	235,815,972	266,981,625	△31,165,653

그리고, 행위별 진료비가 포괄수가 진료비를 초과 한 대상자를 확인 해본 결과, ○○병원의 경우 D과 백내장 양안수술을 하였는데 단안수술로 착오산정하여 청구 하였으며, ■■■·■■■병원에서도 유사한 사례로 충수절제술, 서혜 및 태퇴부 탈장 수술에 대해 복강경을 이용한 수술하였음에도 일반개복수술로 착오산정하여 청구하는 등 [표 3]과 같이 총8건 6,247,240원이 청구가 되지 않았으며 감사기간 중 누락청구한 것이 확인되었습니다.

[표 3] 포괄수가 분류코드 산정착오로 인한 청구 누락 내역

(단위 : 원)

구분	등록번호	환자명	진료과	착오산정		정산산정		차액	사유
				분류코드	총진료비	분류코드	총진료비		
○○	0-----0	***	D과	C05100	1,066,590	C05200	1,990,230	923,640	양안→단안
	2-----3	***	D과	C05100	1,131,590	C05200	2,055,230	923,640	양안→단안
	0-----7	***	D과	C05100	1,070,610	C05200	1,994,240	923,630	양안→단안
■■■	0-----7	***	A과	G08100	2,358,350	G08300	3,072,910	714,560	복강경누락
	9-----7	***	A과	G08200	1,642,173	G08400	2,405,453	763,280	복강경누락
	9-----1	***	A과	G08100	2,221,738	G08300	2,925,728	703,990	복강경누락
	9-----4	***	A과	G08200	1,876,033	G08400	2,645,493	769,460	복강경누락
■■■	0-----6	***	A과	G09630	1,487,250	G09500	2,012,290	525,040	복강경누락
계				8건	12,854,334		19,101,574	6,247,240	

4. 조치할 사항

○ ○○병원장은

- 포괄수가환자의 행위별 진료비가 포괄수가진료비를 초과되지 않도록 포괄수가진료비 분석 자료 등을 해당 진료과와 공유 및 청구누락분 2,770,910원은 회수 조치하시기 바라고 (시정)
- 앞으로 DRG분류번호 산정착오로 누락청구가 발생하지 않도록 관련자에게 『주의』 조치하시기 바라며 (주의)

○ ■■·■■■■병원장은

- DRG분류번호 산정착오로 청구 누락된 3,476,330원을 회수하시고 (시정)
- 앞으로 산정착오로 누락청구가 발생하지 않도록 관련자에게 『주의』 조치
하시기 바랍니다. (주의)